

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

HADS · ESCALA HOSPITALARIA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN

Hospital Anxiety and Depression Scale — Detección bidimensional de distrés afectivo libre de sesgo somático

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial	Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS / HAD)
Autores Originales	R. P. Snaith y A. S. Zigmond (1983)
Validaciones Españolas	Tejero et al. (1986), Caro e Ibáñez (1992), Quintana et al. (2003) y Terol et al. (2007)
Tipo de Instrumento	Autoinforme psicométrico de cribado bidimensional breve
Población Diana	Pacientes ingresados o ambulatorios en servicios hospitalarios médicos/quirúrgicos y atención primaria (16 a 65+ años)
Tiempo de Aplicación	4 a 6 minutos (14 reactivos tipo Likert de 4 opciones)
Formato de Respuesta	Escala de 4 categorías ordinales: 0 a 3 puntos por ítem
Finalidad Clínica	Detección de estados de ansiedad y depresión en pacientes con patología física orgánica, evitando falsos positivos por síntomas somáticos compartidos

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

En los hospitales generales y consultas de especialidades médicas (oncología, cardiología, reumatología), la prevalencia de trastornos ansiosos y depresivos es muy elevada, pero su detección suele estar gravemente distorsionada si se emplean cuestionarios convencionales. Síntomas como la astenia profunda, el insomnio, la pérdida de peso, el enlentecimiento motor y las cefaleas son con frecuencia manifestaciones directas de la enfermedad médica de base o efectos secundarios de la farmacoterapia.

Zigmond y Snaith diseñaron la HADS excluyendo rigurosamente todos los síntomas somáticos y vegetativos, construyendo dos subescalas independientes: a) **HADS-Ansiedad (HADS-A)**, focalizada en tensión psíquica, inquietud interna, aprensión, temor indefinido y dificultad para relajarse; y b) **HADS-Depresión (HADS-D)**, estructurada en torno a la pérdida de placer (anhedonia) y de reactividad emocional ante actividades cotidianas gratificantes. La escala opera así como un indicador puro de distrés psicológico mórbido.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Subescala	Nº Ítems	Ítems Constituyentes y Manifestaciones Evaluadas
HADS-Ansiedad (A)	7 ítems	Ítems impares (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13): Sentirse tenso, miedo a que algo malo ocurra, preocupación constante, incapacidad para estar quieto y pánico.
HADS-Depresión (D)	7 ítems	Ítems pares (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14): Pérdida de ilusión por las cosas, incapacidad de reírse, falta de alegría, pesadez matutina y desinterés.
Puntuación Total HADS	14 ítems	Suma HADS-A + HADS-D (Rango: 0 a 42 puntos; índice global de distrés emocional).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMACIÓN Y REGLAS DE CORRECCIÓN · HADS

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATINOAMÉRICA

Consistencia Interna	Excelente en población hospitalaria española: HADS-Ansiedad (Alfa = 0.83 a 0.86), HADS-Depresión (Alfa = 0.81 a 0.84), Escala Total (Alfa = 0.88 a 0.90; Quintana et al., 2003; Terol et al., 2007).
Estructura Factorial	Análisis factorial confirmatorio ratifica la solución bifactorial ortogonal/oblicua de ansiedad y anhedonia depresiva con índices de ajuste óptimos (CFI = 0.96, RMSEA = 0.048).
Sensibilidad y Especificidad	Con punto de corte ≥ 8 en cada subescala: Sensibilidad = 82-88%, Especificidad = 78-84%, Área Bajo la Curva ROC = 0.89 frente a entrevista psiquiátrica CIE-10/DSM-IV.
Validez Concurrente	Correlación elevada de HADS-A con STAI ($r = 0.74$) y de HADS-D con BDI ($r = 0.70$).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

- Puntuación de Ítems (0 a 3):** Cada ítem se puntúa de 0 a 3 según el nivel de severidad. Algunos ítems presentan redacción inversa para evitar sesgo de aquiescencia.
- Cómputo Separado de Subescalas:**
 - HADS-Ansiedad (HADS-A):** Suma de los 7 ítems impares (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13). Rango: 0 a 21.
 - HADS-Depresión (HADS-D):** Suma de los 7 ítems pares (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14). Rango: 0 a 21.
- Interpretación Clínica Independiente:** Las dos subescalas deben analizarse por separado; la suma total (0-42) representa un índice de malestar psíquico global inespecífico.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación Subescala	Estratificación	Probabilidad Diagnóstica	Conducta Clínica Recomendada
0 a 7 puntos	Normal / Sin Caso	Baja ($< 10\%$)	Bienestar emocional adaptativo. No precisa intervención.
8 a 10 puntos	Caso Dudoso / Dudoso-Leve	Moderada (Corte 8)	Sintomatología subsindrómica; monitorización clínica.
11 a 14 puntos	Caso Clínico Moderado	Alta ($> 80\%$)	Confirmación diagnóstica; valorar intervención activa.
15 a 21 puntos	Caso Clínico Grave	Muy Alta ($> 95\%$)	Cuadro severo; derivación preferente a Salud Mental / Enlace.

PUNTOS DE CORTE DE REFERENCIA (ZIGMOND & SNAITH): El punto de corte de 8 puntos en cualquiera de las dos subescalas se utiliza para estudios epidemiológicos y cribado masivo de alta sensibilidad. Para decisiones de interconsulta psiquiátrica formal se aconseja el corte ≥ 11 puntos, el cual maximiza la especificidad diagnóstica.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y DIRECTRICES · HADS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

Paso 1: Cribado en Hospital General o Primaria: Administrar en pacientes oncológicos, cardiopatas o con dolor crónico.

Paso 2: Segmentación Asistencial:

- Si **HADS-A y HADS-D ≤ 7**: Distrés controlado. No precisa interconsulta psiquiátrica.
- Si **HADS-A ≥ 8 a 10 o HADS-D ≥ 8 a 10**: Intervención psicoeducativa médica, pautas de manejo del estrés por enfermería y reevaluar en 2 semanas.
- Si **HADS-A ≥ 11 o HADS-D ≥ 11**: Solicitar interconsulta a Psiquiatría de Enlace o Psicología Clínica Hospitalaria. En dolor oncológico o post-infarto, valorar inicio de ISRS (ej. sertralina por su excelente perfil cardiovascular y baja interacción farmacológica).

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO (VIGNETTE)

Identificación: Mujer de 52 años diagnosticada de cáncer de mama en estadio II, en tratamiento con quimioterapia adyuvante, evaluada en hospital de día por quejas de astenia extrema e insomnio.

Evaluación Psicométrica Inicial en HADS:

- **HADS-Ansiedad:** 14 / 21 puntos (Caso Clínico Moderado-Grave). Expresa miedo continuo e invasivo a la recidiva tumoral y sensación de tensión muscular que le impide reposar.
- **HADS-Depresión:** 6 / 21 puntos (Rango Normal). Mantiene la capacidad de disfrutar con las visitas de sus nietos, lee libros y muestra una actitud orientada al tratamiento oncológico.

Interpretación y Manejo: El perfil del HADS demostró que la astenia era secundaria a la quimioterapia y no a una depresión mayor (HADS-D normal), aislándose un cuadro puro de Trastorno Adaptativo con Ansiedad severa por amenaza vital. Se inició intervención psicológica en psicooncología (terapia de aceptación y compromiso y desactivación fisiológica) asociada a dosis bajas de lorazepam pautado temporalmente. A las 6 semanas, la subescala HADS-A descendió a 5 puntos, mejorando significativamente su tolerancia al tratamiento quimioterápico.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALERTAS EN PACIENTES MÉDICOS

- Puntuaciones HADS-D ≥ 15 en enfermos crónicos se asocian a una disminución severa de la adherencia a tratamientos médicos vitales.
- Aunque no contiene reactivos suicidas, cualquier puntuación máxima en ítems depresivos exige exploración directa de intencionalidad autolítica.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- **Delirium Hipoactivo:** En ancianos hospitalizados, la apatía puede reflejar un síndrome confusional agudo de causa metabólica o infecciosa.
- **Trastorno de Pánico Somático:** Descartar tromboembolismo pulmonar o arritmias en picos súbitos de ansiedad física.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Zigmond, A. S., & Snaith, R. P. (1983). The Hospital Anxiety and Depression Scale. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 67(6), 361–370.
- Quintana, J. M., Padierna, A., Esteban, C., Arostegui, I., Bilbao, A., & Ruiz, I. (2003). Evaluation of the psychometric characteristics of the Spanish version of the Hospital Anxiety and Depression Scale. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 107(3), 216–221.
- Terol, M. C., López-Roig, S., Rodríguez-Marín, J., Martín-Aragón, M., Pastor, M. A., & Reig, M. T. (2007). Propiedades psicométricas de la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS) en pacientes con cáncer. *Ansiedad y Estrés*, 13(2-3), 163–176.
- Snaith, R. P. (2003). The Hospital Anxiety and Depression Scale. *Health and Quality of Life Outcomes*, 1, 29.